

Клиновидная пластика уретры

Мусабек Е.Б.

АО «Научный центр урологии им. Б.У.Джарбусынова»

К настоящему моменту отечественными и зарубежными исследователями предложено большое количество консервативных и хирургических методов лечения стриктур мочеиспускательного канала у мужчин (Русаков В.И., 1998). Тем не менее, показатели эффективности лечения остаются на достаточно низком уровне. Так, послеоперационный рецидив стриктуры наблюдается в 30-75% случаев, что требует проведения повторных оперативных вмешательств и крайне негативно сказывается на качестве жизни пациентов. Кроме того, нерациональное использование хирургических возможностей приводит к увеличению доли пациентов с протяженными стриктурами мочеиспускательного канала, которым требуется проведение реконструктивных оперативных вмешательств.

Таблица №1. Оценка эффективности оперативного лечения 1 месяц после операции.

Методы исследования	Исследуемая группа	Контрольная группа №1	Контрольная группа №2
IPSS, баллы	8,6±5,3	9,2±4,4	7,9±3,5
Скорость мочеиспускания, мл/сек	13,5±1,2	14,6±1,8	12,9±2,1
QoI, баллы	6,7±1,1	3,5±0,9	5,4±0,8
Объем остаточной мочи, мл	36,5±0,8	37,8±1,0	39,5±1,1
МИЭФ, баллы	18,7±1,3	12,4±1,4	22,9±1,3
p ≤ 0,05 по сравнению с данными до операции			

Таблица №2. Сроки наблюдения через 2 месяца после операции.

Методы исследования	Исследуемая группа	Контрольная группа №1	Контрольная группа №2
IPSS, баллы	7,3±4,9	8,1±4,0	13,7±3,6
Скорость мочеиспускания, мл/сек	15,6±1,2	16,8±1,6	9,7±2,0
QoI, баллы	7,4±1,3	4,1±1,1	3,4±0,7
Объем остаточной мочи, мл	34,4±1,0	37,8±1,0	55,4±1,0
МИЭФ, баллы	20,4±1,1	14,7±0,9	21,6±1,2
p ≤ 0,05 по сравнению с данными до операции			

Предложенный нами метод позволяет повысить качество оперативного лечения, а также снизить количество послеоперационных осложнений. Результатом является повышение числа пациентов с восстановленным самостоятельным мочеиспусканием до 70%. Положительный эффект и хороший результат достигается за счет сохранения сосудистого русла и васкуляризации уретры в зоне анастомоза, что в свою очередь, приводит к ускорению процессов регенерации без образования грубых рубцов в месте анастомоза при пластических операциях.

Способ осуществляется следующим образом. После мобилизации уретры, производится клиновидное иссечение уретры над стриктурой, юретаж рубцовых тканей внутри уретры и продольное ушивание дефекта стенки уретры. При этом сохраняется анатомическая целостность уретры, не повреждается сосудистый рисунок уретры.

Пациентам исследуемой группы оперативное лечение проводилось не резекционным способом, клиновидным иссечением стриктуры. Пациентам контрольных групп №1 и №2, проведены операции по Русакову и лазерная уретротомия соответственно.

Эффективность оперативного лечения оценивалось в сроки через 1, 2 и 4 мес после операции. Использовались такие методы как: урофлоуметрия, определение объема остаточной мочи, оценка по шкалам IPSS, QoL и МИЭФ.

Как видно из таблицы № 1, достоверной разницы по основным показателям не были выявлены, в частности колебания скорости потока мочи составляли не более 2 мл/сек. Однако оценка эректильной функции по шкале МИЭФ, выявили снижение показателей у пациентов которым проведена уретропластика с анастомозом конец-в-конец по Русакову. Тогда как, у пациентов перенесших эндоскопическое вмешательство и не резекционную уретропластику нарушение эректильной функции не было отмечено.

В сроки наблюдения 2 месяца после операции у пациентов контрольной группы №2, которым произведена операция лазерная уретротомия, отмечалось снижение максимальной скорости потока мочи, объема остаточной мочи а также, снижение по шкале IPSS. У двух пациентов из группы контроля №2, которым проводилась операция лазерная уретротомия, в сроки 2 месяца после операции скорость потока мочи снизилась до 7 мл/сек, им было проведено плановое бужирование стриктуры уретры. Данные показателей эффективности лечения представлены в таблице № 2.

Через 4 месяца после операции, у 1-го пациента исследуемой группы отмечалось нарушение мочеиспускания, ему проведено плановое бужирование. У 5 пациентов группы контроля №2, которым произведена операция лазерная уретротомия, отмечалось усиление симптоматики нижних мочевых путей, увеличение объема остаточной мочи, снижение качества жизни и скорости потока мочи. 2 пациентам из этой группы проведено оперативное лечение в объеме уретроанастомоза конец-в-конец, 1 пациенту клиновидное иссечение стриктуры уретры, 2 пациентам повторная операция лазерная уретротомия. У пациентов

Таблица №3. Сроки наблюдения 4 месяца.

Методы исследования	Исследуемая группа	Контрольная группа №1	Контрольная группа №2
IPSS, баллы	9,2±4,3	8,8±4,1	18,4±3,8
Скорость мочеиспускания, мл/сек	14,9±1,2	15,7±1,0	5,1±1,9
QoI, баллы	7,2±1,2	3,0±1,2	3,2±0,9
Объем остаточной мочи, мл	46,5±1,4	40,7±1,3	81,3±1,2
МИЭФ, баллы	20,5±1,2	12,8±1,4	22,3±1,1
p ≤ 0,05 по сравнению с данными до операции			

Таблица №4. Оценка эффективности результатов оперативного лечения.

Пациенты	Результаты					
	Хорошие		Удовлетворительные		Неудовлетворительные	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
1-ая группа n=7	5	71.4	1	14.3	1	14.3
2-ая группа n=8	6	75	1	12.5	1	12.5
3-я группа n=10	2	20	3	30	5	50

контрольной группы №1 (пластика уретры по Русакову) рецидив стриктуры уретры наступил в 1 случае, где проведено плановое эндоскопическое бужирование. Показатели по шкале МИЭФ, у пациентов перенесших резекционную уретропластику были низкими, что объясняется травматизацией сосудов уретры во время операции (табл. 3).

Оценивая результаты исследования и суммируя показатели индикаторов качества оперативного лечения всех групп пациентов, как хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные, мы провели анализ эффективности лечения всех трех групп пациентов и получили следующие результаты (табл.4).

Таким образом, анализируя результаты оперативного лечения, мы пришли к выводу, что способ клиновидного иссечения при коротких стриктурах уретры по эффективности не уступает резекционным методам пластики, а по некоторым параметрам, как сроки удержания уретрального катетера и отсутствие проблем с эрекцией имеет лучшие показатели. Конечно, предложенный нами способ клиновидного иссечения не является методом выбора оперативной коррекции при стриктурах уретры, однако может быть альтернативной резекционной уретропластикой.

Литература

1. Митьков В.В., Хитрова А.Н., Насникова И.Ю. Значение доплерографии в оценке уродинамики // Тез. докл. II съезда Ассоциации ультразвуковой диагностики в медицине. - М.: 1995. - С. 107.
2. Насникова И.Ю. Значение доплерографии в оценке нарушений уродинамики // Дисс. ... канд. мед. наук, М.: 1987.
3. Зубарев А.В., Чепуров А.К., Зайцев Н.В. Возможности лучевой диагностики в выборе тактики лечения сложных стриктурах уретры // Медицинская визуализация-2002г- №2-стр 61-62.
4. Е.Л. Вишневский, Д.Ю. Пушкарь, О.Б. Лоран, В.В. Данилов, А.Е. Вишневский // «Урофлоуметрия» 2002 г.
5. Стрельников А.И. Диагностика различных нарушений уродинамики при инфравезикальной обструкции // Иваново-1998 г.
6. Русаков В.И. Хирургия мочеиспускательного канала. Ростов-на-Дону. 1998.-352с.
7. Амдий Р.Э., Невирович Е.С. Оценка результатов уродинамических исследований при диагностике инфравезикальной обструкции. Нефрология. 2003. Том 7, №4. С.85-89.
8. Симонов В.Я., Козлов С.А. Техника трансуретральной электрорезекции при заболеваниях предстательной железы, мочевого пузыря и шейки мочевого пузыря. Эндоскопическая хирургия и дистанционная литотрипсия. Сборник научных трудов. Москва 1992. С.9-21.